

## 기도폐쇄(성인의 숨길이 이물질로 막힌 경우)

일반적인 상황에서는 기도가 막히는 경우(기도폐쇄)가 발생하지 않지만, 다음의 경우에는 기도가 폐쇄될 수 있으므로 유의해야 합니다.

### 가. 기도가 폐쇄되는 경우는?

- ① 소아나 고령자 : 이물질(사탕, 고기, 땅콩 등)을 삼키다가 기도가 막히는 경우
- ② 외상/사고 : 입안이 손상되어 부러진 치아나 출혈 등에 의해 기도가 막히는 경우
- ③ 의식이 없는 경우 : 혀가 뒤로 말리는 거나, 또는 구토물에 의해 막히는 경우

### 나. 다 막히지 않은 경우 (일부만 막힌 경우)

#### ① 증상 :

환자는 기침과 말을 하며 안절부절 하는 행동을 보입니다. 청색증이 나타나는 경우와 나타나지 않는 경우도 있습니다.

※ 청색증 : 피부가 청자색으로 푸르게 변하는 것을 말함.

#### ② 처치 :

숨이 통하는 경우에는 계속 기침을 하도록 유도하며, 계속해서 기침을 해도 이물질이 배출되지 않을 때에는 즉시 119로 연락을 하여 도움을 요청합니다.

다.

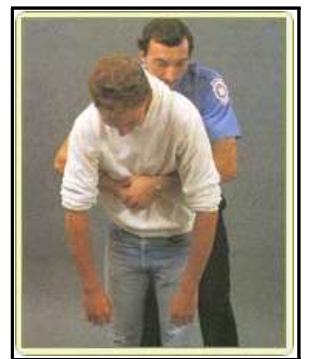
## 다. 짝 막힌 경우

기도가 완전히 막히면 말을 하지 못하면서 양쪽 손으로 목을 쥐는 '축킹-싸인(chocking-sign)'이 나타나면서 얼굴과 입술이 파랗게 변하는 청색증이 관찰됩니다.

※ 축킹-싸인 : 기도폐쇄 환자에서 일반적으로 나타나는 현상 양손으로 목을 감싸거나, 한 손으로 목을 감싸 쥐는 경우도 있습니다.

### ① 정신을 잃지 않고, 숨길이 막힌 환자의 처치법 (복부 밀쳐 올리기)

환자가 정신을 잃지 않았다면  
당신은 환자의 뒤로 돌아가서,  
환자의 허리를 껴안습니다. 당신의 한 손은 주먹을 쥐어 환자의 상복부, 즉 배꼽과 명치 끝의 중간 부분에 대고 다른 손으로는 주먹 권 손을 감싼 후에 환자의 복부를 당신의 가슴 쪽으로 강하게 끌어올리는 방법입니다.



<그림 : 서서하는 복부 밀쳐 올리기>

다. 5회 연속 압박을 실행한 후에는 환자의 입안을 살피고, 입안에서 이물질이 발견되면 제거하

고, 이물질이 관찰되지 않으면 다시 복부 밀쳐 올리기를 5회 시행합니다.

## ② 의식이 없는 환자의 완전 기도폐쇄 처치법



<그림 : 의식 없는 환자 복부 밀쳐  
올리기>

쓰러진 환자를 바로 눕힙니다. 당신은 환자의 옆에 무릎을 대고 앉아서, 한 손으로는 주먹을 쥐어 환자의 상복부, 즉 배꼽과 명치끝의 중간 부분에 대고 다른 손으로는 주먹 권 손을 감싼 후에 환자의 복부를 환자의 가슴 쪽과 등 쪽으로 강하게 쳐 올리는 방법입니다. 5회 연속 압박을 실행한 후에는 환자의 입안을 살피고, 입안에서 이물질이 발견되면 제거하

고, 이물질이 관찰되지 않으면 다시 복부 밀쳐 올리기를 5회 시행합니다.

**Q** 입안에서 이물질이 보이면 즉시 손가락으로 꺼내는 것이 좋은가?

**A** 이물질을 손가락으로 잡으려 하지 말고 손가락 끝으로 훑어내는 방법이 좋습니다. 손가락 끝으로 이물질을 잡으려고 하다는 자칫 이물질을 안쪽으로 밀어 넣을 수 있으므로 손가락을 입안의 측면으로 깊숙이 넣은 다음에 밖으로 훑어내는 방법이 바람직합니다. 이물질이 눈에 잘 보이지 않거나 깊숙한 곳에 있어 꺼내기 힘든 경우에는 잘 못 건드려 오히려 깊숙한 곳으로 밀어 넣을 수 있으므로 시행하지 말아야 합니다. 또한, 환자가 의식이 있을 때는 당신의 손가락을 물 가능성이 높기 때문에 주

의해야 합니다.